

SOAL 10



RESUME RAWAT JALAN

Nama Pasien	: Tn. S****N	Tgl. Masuk	: 28-10-2025
No. RM	: 00-00-00-00	Tgl. Keluar	: 28-10-2025
Tgl. Lahir	: 25-01-1956 (69 tahun)	Lama Dirawat	: 1 hari
No JKN	: *****44**51	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
No SEP	: *****1025V00**	Alergi Obat	: Tidak Ada

Keluhan	Pasien rujukan dari RS C dengan membawa hasil CT Scan Kepala Non Kontras dari RS luar. Pasien memiliki riwayat Cerebral Venous Sinus Thrombosis (CVST) sejak ± 3 bulan lalu. Keluhan saat ini: pasien masih merasakan kelemahan pada lengan dan tungkai kiri (hemiplegia sinistra) yang perlahan membaik, namun masih terasa berat bila beraktivitas lama. Kadang disertai sakit kepala ringan terutama bila kurang istirahat. Tidak ada kejang, tidak ada muntah proyektil, tidak ada penurunan kesadaran. Pasien rutin kontrol dan telah menjalani terapi DAPT (Aspirin 100 mg + Clopidogrel 75 mg) selama 3 bulan, juga menggunakan antikoagulan sebelumnya selama fase akut. Pasien sudah menjalani fisioterapi rutin 2x seminggu namun keluhan belum perbaiki.
Pemeriksaan Fisik	- Keadaan umum: tampak baik, kesadaran compos mentis (GCS 15). - TD: 122/78 mmHg, Nadi: 78x/menit, RR: 18x/menit, Suhu: 36,7°C. - Kepala dan leher: tidak ada tanda peningkatan TIK, nadi retina normal. - Kekuatan otot ekstremitas kanan: 5/5, ekstremitas kiri: 3+/5. - Refleks fisiologis: sisi kiri meningkat (+3), Babinski (+) kiri. - Sensibilitas: masih ada baal ringan di lengan kiri distal.
Pemeriksaan Penunjang	Hasil CT-Scan Cerebral Non Kontras RS Luar : Tampak hiperdensitas linear pada sinus sagital superior dan sebagian sinus transversus kanan yang mengarah pada tanda "dense sinus sign", disertai hiperdensitas kortikal halus di sekitar korteks parietal posterior. Tidak tampak perdarahan intraserebral akut maupun massa intrakranial. Ventrikel simetris, tidak tampak dilatasi. Kesimpulan: Gambaran sesuai dengan kemungkinan Cerebral Venous Sinus Thrombosis (CVST) tahap awal. Saran : pemeriksaan lanjutan MRV (Magnetic Resonance Venography) untuk konfirmasi.
Diagnosis	Cerebral Venous Sinus Thrombosis (CVST) Non Supuratif
Tindakan	MRI Vena Cerebral dengan Kontras Intra Vena
Rencana Tindak Lanjut	Kontrol Baca Hasil MRV pasien pro DSA Stand By trombolisis endovaskular dengan Alteplase 0,1 mg/kg/jam selama 6 jam. Monitoring kesadaran dan tekanan darah. Lanjutkan NOAC/warfarin sesuai protokol.
Poliklinik	Saraf Intervensi
Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)	(ITE) dr. N*** A****., SpS



EXPERTISE RADIOLOGI

Nama Pasien	: Tn. S****N	Tgl. Masuk	: 28-10-2025
No. RM	: 00-00-00-00	Tgl. Order	: 28-10-2025
Tgl. Lahir	: 25-01-1956 (69 tahun)	Tgl. Hasil	: 31-10-2025
No JKN	: *****44**51	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
No SEP	: *****1025V00**	Alergi Obat	: Tidak Ada

Nama Pemeriksaan

MRV (Magnetic Resonance Venography) Cerebral

Indikasi Klinis

Sakit kepala hebat sejak beberapa hari, disertai mual dan muntah. Tidak ada riwayat trauma kepala. Evaluasi kemungkinan Cerebral Venous Sinus Thrombosis (CVST).

Teknik Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan sekuens MR angiografi vena otak (2D TOF dan 3D PC), potongan aksial, koronal, dan sagittal.

Hasil / Temuan

- **Tampak hilangnya aliran (flow void) pada sinus sagittalis superior, sinus transversus kanan, dan sebagian sinus sigmoid kanan, sesuai gambaran trombosis vena serebral tidak terlihat adanya pus/nanah.**- Tampak peningkatan sinyal T1/T2 pada sinus tersebut.- Sinus transversus kiri dan vena internal serebral kiri masih tampak normal.- Parenkim otak dalam batas normal, **tidak tampak edema difus maupun infark vena yang nyata.**- Ventrikel lateral simetris, garis tengah tidak bergeser.

Kesan MRV

Gambaran sesuai dengan Cerebral Venous Sinus Thrombosis (CVST) melibatkan: • Sinus sagittalis superior • Sinus transversus kanan • Sinus sigmoid kanan, tanpa pus atau nanah.

KESAN AKHIR

➡ Cerebral Venous Sinus Thrombosis (CVST) pada sinus sagittalis superior, transversus kanan, dan sigmoid kanan. Tidak tampak perdarahan atau infark vena yang nyata pada parenkim otak.

(TTE)

Dibuat oleh

dr., Sp.Rad

Spesialis Radiologi

Tanggal

31-10-2025